



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نادية محمد جمال الدين الجزار
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : دار السلام
رقم البطاقة : 26310241701783 رقم التليفون : 01118196942
العمر (تاريخ الميلاد) : 24-10-1963 المهنة : ربه منزل
العنوان : 2 ش محمود سليمان
تاريخ تسجيل الإستمارة : 02-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]
قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نادية محمد جمال الدين الجزار National ID: 26310241701783	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



مبادرة رئيس الجمهورية
لدمج المرأة المصرية

Ժողովուրդ
 Լի
 Ժողովուրդ
 Ժողով

• 11/11/19 7920

MDT FORM 6 / 11 / 2022 G

<u>Name</u>	Dr. Basak	<u>MRN</u>	0211.5210.100
<u>Age</u>	64-65	<u>ID</u>	PCP/C.C.
<u>Menopausal status</u>		<u>Phone</u>	118940209
<u>NRS SCORE</u>		<u>Marital status</u>	
<u>BMI</u>		<u>Family history</u>	
<u>CO morbidity</u>		<u>REASON OF MDT</u>	

Clinical Data

BX:	R			L
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:	
<u>Sonomammography:</u>				
<u>Mets Workup:</u>				TNM

Received 6 X Path

Received 6 X 12 H P

Recommendations: post op → bilateral MRM.

Qr $\rightarrow$ Complete path Response. LN 0117 First margin

④ $\rightarrow$ Complete path. Respiration $\rightarrow$ N OIT free margins

MDT OUTCOME & PLAN

WOLF PORT

2) AI for 5 years

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. ناصر ابو د. شمس الدين		د. احمد			

SMC 1941 MDT-DOJ
B-111-266 (1)



Patient Name : الأستاذة / نادية محمد جمال
Patient No. : 26310241701783
Path No. : 265/2022
Sex : Female
Age : 58 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13001759
Request Date : 31/01/2022
Verification Date : 01/03/2022
Financial Category : أورام نادر - أورام
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Rt & Lt breast mass

Nature of the specimen: tru cut

Gross Examination:

) multiple gray white tissue cores up to 2cm, totally submitted

) multiple gray white tissue cores up to 1.4cm, totally submitted

Sections prepared from paraffin block for Immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, R, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:

Histological type: Bilateral IDC

Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): GII(2+2+1)

Angiolymphatic invasion: NO

Ductal carcinoma in situ: positive

Tumor extent

Number: N/A

Size: N/A

Skin involvement: N/A

Lymph node involvement: N/A

Resection Margins: N/A

Histologic response to therapy: N/A

Additional pathologic findings: N/A

Specimen (1):

Examination of ER stained slide show intense nuclear staining in 70% of the tumor cells.

Examination of PR stained slide show moderate nuclear staining in 90% of the tumor cells.

Examination of HER2 stained slide show no membranous staining in tumor cells.

Verified by :

walaa ghoniem

Printing Date : 01/03/2022 09:55:12

Page 1 of 3

Printed By : Ali mostafa

Ministry of Health - State of Palestine
Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - مختبر الأمراض النسائية

Patient Name : 13003630 / 17/09/2022
Patient No : 26310241701783
Path No : 2734/22
Sex : Female
Age : 58 Y
Referring Doc :

Request No : 13003630
Request Date : 17/09/2022
Verification Date : 27/10/2022
Financial Category : مريض - Out Patient
Department :
Registered by : Ali Mostafa

Pathology Report

Clinical Data

Bilateral breast cancer, Post NACT

Nature of the specimen:
Bilateral MRM

Gross Examination:

- * Right MRM measured 32x29x5 cm with covering skin measured 20x12 cm, covering skin, nipple & areola were unremarkable grossly, sectioning revealed an ill-defined tumor bed site, 6x3x1 cm, located 3 cm from deep margin, 3.5 cm from the skin. Axillary dissection revealed 17 nodules up to 2 cm in diameter. Rest of breast showed scattered foci of grayish white rubbery area.
- * Lt MRM measured 35x29x6 cm with covering skin measured 35x29 cm, covering skin, nipple & areola were unremarkable grossly, sectioning revealed an ill-defined tumor bed site, 6x5x4 cm, located 1 cm from deep margin, 1.5 cm from the skin. Axillary dissection revealed 17 nodules up to 1 cm in diameter. Rest of breast showed scattered foci of grayish white rubbery area.

Microscopic examination

Right MAM:

- * Total tumor regression.
- * Complete pathological response.
- * Skin involvement: Free.
- * Lymph node involvement: No (0/17).
- * Resection Margins: Free.
- * Free nipple & areola.
- * Histologic response to therapy: Complete pathological response.
- * Additional pathologic findings: Hyalinosis, Necrosis, Fibrosis in surrounding breast.

Verified by

Dr. Marwa Mahmoud

Printing Date: 19/10/2022 11:37:30

Page 1 of 3

Printing By: Ali Mostafa

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED:-

1. Chest:

- Left breast UOQ shows Irregular mass measuring about 4.9x4.9 cm with overlying thickened skin.
- Left axillary level I, II and III amalgamated enlarged lymph nodes are seen the largest measures about 27x26 mm.
- Left supraclavicular and left posterior cervical enlarged lymph nodes are seen the largest is at the latter measuring about 17x13 mm.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Right thyroid hypodense nodule is seen measuring about 13 mm.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous CT texture. Left hepatic lobe intensely enhancing focal lesion is seen at segment III measuring about 15x12 mm.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No Intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus is seen with multiple masses likely uterine fibroids.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Skeletal examination revealed:
 - Dorsolumbar spondylotic changes are seen.
 - 1st degree L4/5 degenerative spondylolisthesis.
 - D12 vertebral body tiny sclerotic bone lesion is seen likely bone island.

OPINION:

- Left breast mass with left axillary level I, II and III as well as left supraclavicular and left posterior cervical enlarged lymph nodes.
- Left hepatic lobe intensely enhancing focal lesion likely hemangioma for local US confirmation.

Dr. Reham Anwar, MSc, FEBR

Dr. Amy Farouk MD

DATE: 10/03/2012
CASE NO: 1002301

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- 59-year-old lady presented with history of breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- No evidence of bone secondaries could be seen.
- Degenerative changes are noticed at different levels of the spine.
- Osteoarthritic features are observed at the both knees.

IMPRESSION

- The skeleton is free from metastases.

*Much obliged,
Dr. Alaa Nagl, MD
Nuclear Medicine*